המועצה המדעית
SCIENTIFIC COUNCIL
ההסתדרות הרפואית בישראל
Israeli Medical Association
חיבור רפואי זו
ההתמחות שלבו

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א'

גריאטריה

13.06.23

מס' השאלות בחלק זה: 150

התמחות בסיס

1. בן 83, בשנה האחרונה סובל מקוצר נשימה במאמץ ומדווח על בצקת ברגליים.
איזה שינוי של הזדקנות המערכת הקרדיווסקולארית יכול להסביר את תלונותיו?

א. אמילוידוזיס של שריר הלב
ב. הרחבה של העורקים הקורונריים
ג. איבוד סיבים במערכת ההולכה
ד. פיברוזיס של המיוקרדיום

2. מה מתאר בצורה נכונה את הבקרה העצבית על שלפוחית השתן?

א. המערכת הסימפטטית מופעלת בזמן מילוי השלפוחית ומונעת התרוקנות מוקדמת
ב. המערכת הפראסימפטטית מרפה את השריר של השלפוחית
ג. המערכת הסימפטטית משפיעה על הטונוס של שרירי רצפת האגן
ד. המערכת הסימפטטית גורמת לתחושת הרגשת דחיפות במתן שתן

3. בן 80, ברקע: דמנציה, יתר לחץ דם, סוכרת, אלכהוליזם, גר לבד. מטופל ב-
ENALAPRIL, METFORMIN, התקבל לאחר נפילה ושבר בצוואר הירך.
איזה מהנתונים אצל המטופל הוכחו במחקרים באיכות גבוהה כגורם סיכון גבוה לנפילות?

א. דמנציה
ב. סוכרת
ג. אלכוהוליזם
ד. הטיפול התרופתי שמקבל

4. מי מהגנים הבאים הוא גורם סיכון למחלת אלצהיימר?

א. LARC על כרומוזום 12
ב. NOT3
ג. אלל -APOE2
ד. APP על כרומוזום 21

5. בן 70, שנה לאחר אירוע מוחי. הוא יכול לומר " חלש ... יד ", "לך מפה", "תן...ארוחת ערב", הוא מסוגל להרים יד שמאל, להראות לשון, לסגור עיניים. הוא לא יכול לחזור על משפט, יד ימין חלשה אך הוא יכול ללכת.

מה סוג האפזיה של מטופל זה?

א. FLUENT APHASIA

ב. CONDUCTION APHASIA

ג. NON FLUENT APHASIA

ד. ANOMIC APHASIA

6. איזו פגיעה בראיה היא גורם הסיכון המשמעותי ביותר לנפילה?

א. ירידה בחדות הראייה (acuity)

ב. ירידה ברגישות לסנוור (glare)

ג. ירידה בהסתגלות לחושך (adaptation)

ד. ירידה ברגישות לניגודיות (contrast)

7. בן 84, סובל מדמנציה מסוג אלצהיימר מזה שנתיים. פנה למרפאה עקב ירידה תפקודית. לדברי המשפחה הוא ממעט לצאת מהבית ומסתובב בבית באי שקט. לעיתים בוכה במשך היום ומתרגז על דברים קטנים. הוא ישן הרבה ומסרב לצאת מהמיטה. בשיחה - מתקשה לבטא מה מפריע לו, אך פורץ בבכי במהלך השיחה כשנשאל על הקשר עם משפחתו.

אומדנים- MMSE - 22/30, PHQ2 - 5/6.

מה הטיפול התרופתי המומלץ בשלב ראשון?

א. ESCITALOPRAM

ב. DONEPEZIL

ג. VENLAFAXINE

ד. MIRTAZAPINE

8. בת 78, תשושה בתפקודה, ללא חסר קוגניטיבי. ברקע: סוכרת עם נפרופתיה ויתר לחץ דם. עקב אירוע של TIA עברה בדיקת דופלר קרוטידים ואובחנה היצרות של 50% ב- INTERNAL CARODID מימין.

מה האופציה הטיפולית המתאימה?

א. טיפול תרופתי כולל נוגדי טסיות, סטטינים, איזון סוכרת ויתר לחץ דם

ב. Carotid artery stenting

ג. Carotid endarterectomy

ד. ההחלטה הטיפולית תלויה בתוחלת החיים הצפויה

9. על פי המאמר Time to Clinical Benefit of Intensive Blood Pressure Lowering in Patients 60 Years and Older With Hypertension מאת Chen וחבריו ב- JAMA 2022 מה ההשפעה של איזון אגרסיבי של לחץ הדם על MACE- Major adverse cardiovascular events ?

א. לא הוכחה יעילות של איזון אגרסיבי של לחץ הדם במניעת MACE באנשים בני 60 ומעלה

ב. האיזון האגרסיבי מונע אירוע אחד של MACE ל- 100 אנשים בשלוש שנים

ג. איזון אגרסיבי של לחץ הדם מומלץ רק באנשים שתוחלת חייהם המשוערת היא יותר מ- 5 שנים

ד. איזון אגרסיבי של לחץ הדם הוכח רק במטופלים עם סוכרת

10. בן 84, מאובחן כסובל מדמנציה מסוג אלצהיימר בחומרה בינונית עד קשה. לאחרונה הופיעו הפרעות הכוללות תוקפנות, אגיטציה, הזיות ראיה, וחוסר עכבות, שמהוות מטרד משמעותי למשפחה. לאחר בירור מדובר כנראה בתסמינים נוירו-פסיכיאטריים.

איזה מהבאים נכון בנוגע לטיפול המתאים במצב המתואר?

א. פסיכותרפיה היא טיפול הבחירה, במיוחד עבור חולים עם דמנציה בחומרה קשה

ב. תרופות אנטיפסיכוטיות אטיפיות מאושרות כקו טיפול ראשון על-ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) למצב המתואר

ג. תוקפנות הגורמת נזק או סיכון לנזק עצמי או לאחרים מהווה התוויה לשימוש בתרופות אנטיפסיכוטיות

ד. יש להתחיל בתרופות אנטי פסיכוטיות במינון גבוה, אין זמן לביצוע טיטרציה בנוכחות אגיטציה

11. בת 92, מאושפזת לאחר שבר בצוואר הירך. יומיים לאחר הניתוח התחילה לצעוק באמצע הלילה ולנסות לצאת מהמיטה. אובחנה כסובלת מדליריום.

מה השלב הבא?

א. טיפול ב- HALPERIDOL במינון 0.5 מ"ג

ב. הדרכת המשפחה לטיפול סביבתי

ג. טיפול ב- LORIVAN במינון 1 מ"ג

ד. בירור סיבת הדליריום

12. בן 80, פונה למחלקה לרפואה דחופה בשל פריחה כואבת בפנים שהתחילה 4 ימים טרם קבלתו וכן כאבים בעין ימין וטשטוש ראייה (ראו תמונה מספר 1). המטופל מעדכן שלא הופיעו שלפוחיות חדשות מאתמול.

בבדיקות דם: תפקודי כליה תקינים, אנזימי כבד תקינים, ספירה בגדר הנורמה.

מה הטיפול המתאים לחולה בנוסף לטיפול מקומי בעין?

א. ACYCLOVIR 800 mg חמש פעמים ביום

ב. משחת ACYCLOVIR על הנגעים בעור

ג. מעקב וטיפול תומך בלבד

ד. FAMCYCLOVIR 500 mg חמש פעמיים ביום

13. בן 65, ברקע מחלת פרקינסון, מדווח על נפילות חוזרות בחודשיים האחרונים. על פי התיאור מדובר ב- FREEZE ונפילה לאחור. ביעוץ נוירולוגי לא הומלץ על שינוי תרופתי.

מה אביזר העזר להליכה המתאים ביותר במצב המתואר?

א. מקל 4 נקודות (קוודריפוד)

ב. הליכון 2 גלגלים

ג. הליכון 4 גלגלים (רולטור)

ד. הליכון רגיל (ללא גלגלים)

14. בן 88, מזה שנתיים מרותק למיטה, עד לאשפוז הנוכחי התגורר בביתו עם עובד זר. אושפז עקב דלירים, אצירת שתן וזיהום בדרכי השתן. במהלך האשפוז פיתח פצע לחץ. בסיום האשפוז הוחלט שישתחרר למסגרת מוסדית.

מה השיקול הנכון בהתאמת המסגרת המוסדית?

א. אם עדיין סובל מדלירים מתאים למחלקה לתשושי נפש

ב. אם הוא מרותק למיטה זקוק לניסיון שיקומי לצורך הגדרה אם הוא תשוש או סיעודי

ג. אם נשאר עם צנתר בדרכי השתן מוגדר כ"סיעודי מורכב"

ד. אם פצע הלחץ הוא דרגה 2 ומטה מתאים לאשפוז במחלקה סיעודית

15. בן 85, סובל מירידה קוגניטיבית מלווה בנפילות חוזרות. סובל מהפרעות קשות בשינה עד כדי שאישתו עברה לישון בחדר נפרד. המשפחה מספרת על מקרה בו דיבר לנוסע שכביכול היה איתו ברכב, אך הסתבר שהיה בו לבדו.

על איזה מהטיפולים הבאים כדאי להמליץ בשלב הראשון?

א. מעכבי CHOLINESERASE

ב. LEVODOPA

ג. MIRTAZAPINE

ד. OLANZAPINE

16. איזה מההיגדים הבאים מתאר נכונה את השינויים בתפקוד הכלייתי בזקנים?

א. פרוטאינוריה מהווה שינוי פיזיולוגי צפוי בזקנים בשל הירידה ב- Glomerular Filtration Rate (GFR)

ב. עם הגיל מופיעה היפרפילטרציה כפיצוי על הירידה במסת הכליה

ג. במצבי Stress ההפרשה החלקית של אשלגן בכליה יורדת

ד. בפתולוגיה ניתן לראות התעבות של ה- basement membrane

17. בן 70, מאושפז במחלקת שיקום לאחר דימום מוחי תת-עכבישי (Subarachnoid Hemorrhage). הדימום נספג. בעקבות הדימום המטופל פיתח חולשה קלה בפלג גוף ימין. כשבועיים אחרי האירוע התחיל להתלונן על קשיי הליכה עם חוסר יציבות, בעיות שליטה על סוגרים וירידה בזיכרון. CT מוח שלל דימום חדש.

מה הצעד הבא המתאים ביותר?

א. טיפול ב-DONEPEZIL

ב. טיפול ב-LEVODOPA

ג. LUMBAR PUNCTURE

ד. בדיקת EEG

18. בת 74, א-סימפטומטית, עשתה בדיקות דם שגרתיות. עקב שקיעת דם מוחשת נמצא חלבון מונוקלונלי IgG קאפא.

כיצד ניתן לאבחן שמדובר ב- MGUS (MONOCLONAL GAMMOPATHY OF UNCERTAIN SIGNIFICANCE) ולא ב- MULTOPLE MYELOMA?

א. ב- MGUS יש חלבון מונוקלונלי IgG פחות מ- 30 גרם/ליטר

ב. ב- MGUS יש פחות מ- 30% תאי פלסמה במח העצם

ג. ב- MGUS ההמוגלובין בסביבות 10

ד. ב- MGUS אין חלבון מונוקלונלי בשתן

19. מה הגישה הטיפולית ב- CARCINOMA OF PANCREAS בקשישים?

א. בגיל 75 ומעלה הסיכון הניתוחי עולה על התועלת

ב. במחלה לא נתיחה שילובי כימותרפיה המכילים ADRIAMYCIN הראו יתרון הישרדותי על משלבים אחרים

ג. טיפול כימותרפי ב-GEMCITABINE בקשישים כרוך בסיכון גבוה ל- FEBRILE NEUTROPENIA

ד. לכאב עמיד ניתן לשקול CELIAC PLEXUS BLOCK

20. על מנת להגדיר סרקופניה דרוש שילוב של מספר קריטריונים. כל קריטריון נמדד בדרכים שונות.

איזו מהבאות היא דרך נכונה למדידה של קריטריונים לסרקופניה?

א. מדידת כוח שריר בשימוש ב Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA)

ב. מדידת מסת שריר בשימוש בכוח לחיצה Hand Grip

ג. מדידת כוח שריר בשימוש ב The Short Physical Performance Battery (SPPB)

ד. מדידת מסת שריר בשימוש ב Bioimpedance Absorptiometry (BIA)

21. בן 85, מתלונן על חולשה, איבוד תיאבון, כאבי בטן ובחילה. במדידות חוזרות של לחץ דם נמדדו ערכים על הגבול הנמוך (95/65).

בבדיקות המעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	134	135-146
K mmol/L	5.1	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	0.9	0.7-1.3
BUN mg/dL	24	5-25

שעה לאחר הזרקת 250 מק"ג CORTICOTROPIN רמת קורטיזול 10 mg/dL (תקין מעל 18).

מה ההמלצות לגבי הטיפול התרופתי?

א. טיפול ב- HYDROCORTISONE 20 מ"ג בבוקר + 10 מ"ג בערב

ב. טיפול משולב ב- HYDROCORTISONE ו-FLUDROCORTISONE

ג. בזמן מחלת חום יש לקחת טיפול פי 3 מהמינון הקבוע

ד. טיפול ב- PREDNISONE במינון 10 מ"ג

22. בת 83, שמורה קוגניטיבית, ברקע - קרצינומה מטסטטית של המעי הגס. לאחרונה הופסק טיפול כימותרפי עקב התקדמות המחלה, וסבל רב של החולה. לחולה הנחיות מקדימות לפי חוק החולה הנוטה למות אותן מילאה לפני שנתיים וכתבה שהיא מבקשת להימנע מכל טיפול פולשני מאריך חיים.

התקבלה לאשפוז עקב אי ספיקה כלייתית חדה עם עליית קריאטינין ל- 8 ואשלגן ל-7. בבדיקת אולטרסאונד נמצא הידרונפרוזיס קשה מימין.

החולה מודעת למצבה ומבקשת שיחה עם הצוות המטפל לגבי האפשרויות הטיפוליות.

איזה מהבאים נכון בנוגע לטיפול במצב המתואר על פי חוק החולה הנוטה למות?

א. במידה ותזדקק לדיאליזה יש להימנע לפי ההנחיות המקדימות

ב. חובה לטפל בהיפרקלמיה היות וזו פעולה מצילת חיים

ג. יש לטפל בה לפי רצונה גם אם הוא סותר את ההנחיות שכתבה

ד. לא ניתן להימנע מהכנסת נפרוסטום גם אם החולה מתנגדת לכך, היות והוא נחשב טיפול במחלות נלוות

23. בן 71, סיעודי, סובל מדמנציה קשה עם הפרעות התנהגות ופצע לחץ בדרגה 4, מאושפז במחלקה לסיעוד מורכב. הצוות מתרשם מאי שקט פסיכומוטורי ושואל האם מדובר בכאב. כיצד ניתן להעריך את עוצמת הכאב במטופל זה?

א. שימוש בסרגל כאב PAINAD

ב. שימוש בסולם NRS בעזרת המשפחה של המטופל

ג. שימוש בסרגל עם פרצופים המשקפים דרגת כאב

ד. שימוש בסרגל צבעים כאשר צבע לבן משקף שאין כאב וצבע אדום משקף כאב חזק

24. בן 87, סובל מסוכרת שנים רבות. מזה שנתיים ללא טיפול תרופתי. ברקע – מחלת אלצהיימר, גר עם מטפל צמוד ומתנייד עם הליכון. המטפל מדווח שהמטופל מרבה לשתות ומטיל שתן בתכיפות גדולה. ירד במשקל 6 ק"ג בחודשים האחרונים.

במעבדה המוגלובין A1C – 11%.

על פי המאמר ADA Older Adults: Standards of Medical Care in Diabetes-2022 מה הטיפול המומלץ?

א. התחלת טיפול באינסולין ארוך טווח וטיטרציה עד לשיפור בתסמיני ההיפרגליקמיה

ב. מעקב ערכי סוכר 3 פעמים ביום והתאמת טיפול באינסולין קצר טווח לפי טבלה

ג. בגילו ובמצבו אין צורך להקפיד על איזון סוכרת

ד. התחלת טיפול באנלוגים של GLP1 ומעכבי SGLT2

25. מה מאפיין את הזדקקות הקשישים לעזרה על פי לקט הנתונים של מכון ברוקדייל?

א. גברים בגיל 80 ומעלה מקבלים גמלת סיעוד יותר מנשים

ב. יותר מ-30% מהאנשים בגיל 75 ומעלה מתקשים בהליכה או בעליית מדרגות

ג. יותר מ- 50% מהאנשים מעל גיל 65 זקוקים לעזרה במשק בית

ד. רוב האנשים מעל גיל 65 מעסיקים עזרה בתשלום

26. מה מהווה אינדיקציה לשימוש בחמצן בחולה COPD?

א. סטורציה נמוכה או שווה ל-89% במטופל עם אי-ספיקת לב ימנית

ב. סטורציה נמוכה או שווה ל-89% במטופל עם רמת המטוקריט מעל 50%

ג. PaO2 נמוך מ- 59 mm Hg במנוחה ללא מחלות רקע נוספות

ד. PaO2 נמוך מ- 65 mm Hg עם COR PULMONALE

27. בת 76, מאושפזת לברור חולשה וסחרחורת שהופיעו מזה כחודש. היא מדווחת על טשטוש ראיה, קושי בבליעה והתעייפות לאחר מאמץ קל. בבדיקה נוירולוגית: טונוס מעט מופחת, פטוזיס, חולשת שרירים פרוקסימלית, דיסארטריה, ללא פגיעה קוגניטיבית. CT מוח לא הדגים פתולוגיה משמעותית.

מה בדיקת העזר המומלצת?

א. ANTI-AChR RADIOIMMUNOASSAY בדם

ב. OLIGOCLONAL ANTIBODIES בניקור מותני

ג. CERULOPLASMIN בדם

ד. Anti-GQ1b IgG ANTIBODIES בדם

28. מה מאפיין פרכוס לעומת SYNCOPE?

א. התעוררות מהירה לאחר האירוע

ב. כאבי שרירים

ג. טשטוש ראיה לפני האירוע

ד. פעילות מוטורית של פחות מ- 10 שניות

29. בת 75, עצמאית בתפקודה. ברקע סוכרת, יתר לחץ דם וקרצינומה של הקולון שאובחנה לפני 5 שנים. אושפזה עקב פריחה (ראו תמונה 2), כאבי רגליים וירידה תפקודית. בבדיקת כימיה: CPK- 1235.

איזה ממצא אופייני יהיה בבירור?

א. בבדיקת אימונוגלובולינים כמותית – IgE גבוה

ב. בביופסיית שריר – תסנין פולימורפונוקלארי סביב כלי הדם

ג. ב- EMG - שינויים מיופתים בשרירים פרוקסימלים

ד. עליה ב- C3 ו- C4 בדם

30. בן 88, לאחר שבר בצוואר הירך וניתוח TOTAL HIP REPLACEMENT, מתלונן על עצירות וכאב בטן. בבדיקה גופנית: בטן תפוחה ורגישה עם פריסטלטיקה מופחתת.

צילום בטן – ראו תמונה 3 .

מה ההפרעה האלקטרוליטרית השכיחה במקרה זה?

א. היפוקלצמיה

ב. היפוקלמיה

ג. היפונתרמיה

ד. היפוגליקמיה

31. בן 84, ברקע: סוכרת, עישון, יתר לחץ דם, אירוע מוחי לפני 5 שנים. מתוכנן לניתוח כריתת גוש בריאה ימנית. כהכנה לניתוח עבר בדיקת אקו לב.

מה מהווה גורם סיכון ל-Major Adverse Cardiovascular Events (MACE) לאחר הניתוח?

א. במידה והתפקוד הסיסטולי תקין – אין סיכון מוגבר ל-MACE

ב. אירוע מוחי בעבר הוא גורם סיכון ל-MACE

ג. הזדקנות מערכת ההולכה הלבבית מגבירה סיכון לטכיאריתמיות תרופתיות

ד. LVEF-50% הוא גורם סיכון בלתי תלוי ל-MACE

32. בתמונה 4 פצע לאחר שבועיים של טיפול מקומי להטריה אוטוליטית.

לאור הממצא בשוליים, מהו הטיפול המומלץ כעת?

א. הטרייה כירורגית של הרקמה הלבנה ושימוש מקומי במשחה סטרואידלית

ב. אפליקציה של METRONIDAZOLE מרוסק על השוליים וכיסוי בחבישה משנית

ג. טיפול בהרטבות NaCl מספר פעמים ביום

ד. שימוש בחבישה בעלת כושר ספיגה גדול

33. באיזה מהבאים מתואר שילוב נכון של סוג הדמנציה והפרזנטציה הקלינית השכיחה?

א. דמנציה וסקולרית – תסמינים קוגניטיביים פלוקטואטיביים עם פגיעה בקשב

ב. דמנציה עם גופיפי לוי (LBD) – ירידה קוגניטיבית אקוטית בעיקר בזיכרון קצר טווח

ג. אלצהיימר – פגיעה בזיכרון ארוך טווח וחסרים נוירולוגיים פוקליים

ד. דמנציה פרונטו-טמפורלית (FTD) – הפרעה בשפה עם זיכרון שמור יחסית

34. איזה מהבאים הוא צירוף נכון של תרופה לעצירות עם תופעת לוואי שלה?

א. MINERAL OIL (שמן פרפין) -> Lipid Pneumonia

ב. חוקן PHOSPHATE –> עליה בסיכון לזיהומי Clostridium Difficile

ג. BISACODYL - > היפרקלצמיה

ד. PSYLLIUM -> תת ספיגה של ויטמין D

35. בן 79, סובל ממחלת אלצהיימר עם MMSE 22/30. ללא הפרעות התנהגות. ברקע פרפור עליות עם טיפול בחוסמי בטא ונוגדי קרישה.

מה נכון לגבי הטיפול התרופתי ותופעות הלוואי האפשריות?

א. טיפול ב- GINGKO BILOBA יעיל במצבו אך קיימת קונטראינדיקציה עקב טיפול בנוגדי קרישה

ב. טיפול ב- DONEPEZIL יכול לגרום לסינוס טכיקרדיה

ג. טיפול ב- MEMANTINE יכול להינתן לאנשים עם אי סבילות למעכבי CHOLINESTERASE

ד. טיפול ב-ADUCANUMAB במסגרת מחקרית הראה תופעות לוואי הדמייתיות אך ללא חשיבות קלינית

36. בן 84, ברקע הגדלה שפירה של בלוטת הערמונית, ללא אנמנזה של סרטן ערמונית או התערבות אורולוגית בעבר. מדווח על אי-שליטה על סוגר השתן שנמשכת כבר תקופה ממושכת. הוא מדווח שהוא כמעט תמיד רטוב בשל איבוד שליטה על סוגר שתן. כאשר מגיע לשירותים הוא מרגיש עיכוב וקושי בהטלת שתן, מדווח על זרם חלש ומקוטע או בסוף טפטוף ממושך של השתן.

מה השלב הבא בבירור?

א. שתן לכללית ותרבית

ב. ציסטוסקופיה

ג. בדיקה אורודינמית

ד. אולטרסאונד שלפוחית עם בדיקת שארית

37. מה הסיבה השכיחה להחמרה באי-ספיקת לב בגיל הזקנה?

א. תופעות לוואי של תרופות

ב. היענות ירודה של מטופלים לנטילת תרופות ולדיאטה

ג. מחלות זיהומיות חריפות, כגון: דלקת ריאות או דלקת בשלפוחית השתן

ד. הפרעות בתפקודי בלוטת התריס

38. בת 78, תשושה בתפקודה ושמורה קוגניטיבית סובלת מממאירות שד עם גרורות לעצמות. מתלוננת על כאבים עזים בגב. מטופלת ב- ACAMOL במינון 3 גרם ליום ו- OPTALGIN במינון 3 גרם ליום ללא הקלה מספקת.

מה המשך הטיפול בכאבים?

א. להוסיף לטיפול מדבקת FENTA

ב. להוסיף לטיפול T. LYRICA

ג. להוסיף לטיפול T. PERCOCET

ד. להוסיף לטיפול syr. OXYCOD

39. בן 88, שמור קוגניטיבית, מרותק לכיסא גלגלים לאחר CVA, מתגורר עם עובד זר, מטופל בהמודיאליזה מזה 4 שנים. לאחרונה פנה לצוות וביקש להפסיק את טיפולי הדיאליזה.

מה הגישה במקרה זה?

א. יש לברר עם המטופל שהחלטתו לא נובעת מדיכאון

ב. אסור להפסיק טיפול בדיאליזה אם המטופל לא מוגדר כ"חולה נוטה למות"

ג. יש למנות למטופל מיופה כוח שיסכים במקומו להפסקת הדיאליזה

ד. ניתן להפסיק דיאליזה ולשחרר את המטופל למעקב רופא המשפחה

40. בן 70, מזה כשלוש שנים פגיעה קשה ביציבות, מלווה בנפילות חוזרות. בנוסף, מציין הפרעה בדיבור ובבליעה.

בבדיקתו: אורטוסטטיזם משמעותי, ללא עדות לרעד, כוח גס תקין, החזרים מאד ערים, הליכה לא יציבה על בסיס רחב. במהלך הבדיקה סבל מאירוע של סטרידור.

מהי האבחנה הסבירה ביותר?

א. VASCULAR DEMENTIA

ב. MULTIPLE SYSTEM ATROPHY - CERBELLAR

ג. PARKINSON'S DISEASE

ד. HUNTINGTON CHOREA

41. בן 82, לאחר דימום מוחי, התקשה באכילה עקב קושי בבליעה. מכיוון שלא נצפה שיפור במהלך השיקום הוחלט לאחר חודש להתחיל הזנה אנטרלית דרך זונדה.
איזו הפרעה אלקטרוליטרית יכולה להופיע בימים הראשונים להזנה האנטרלית?

א. היפופוספטמיה משנית לכניסת פוספט לתאים
ב. היפוקלצמיה משנית לחסר זמני של ויטמין D
ג. היפרנתרמיה משנית לשחרור מוגבר של ADH
ד. היפרקלמיה משנית להרס תאי שריר

42. למי מהמטופלים הבאים הכי מתאים טיפול ב VISMODEGIB (תרופה מסוג Hh pathway inhibitor)?

א. בן 80 עם מלנומה בלחי ימין
ב. בת 75 עם BCC המערב עפעף תחתון משמאל
ג. בת 92 עם SCC על גשר האף
ד. בן 70 עם BCC חוזר בקרקפת

43. מה נחשב לשינוי נורמלי בשינה בגיל המבוגר?

א. זמן הירדמות ארוך יותר
ב. עליה בחלק של שנת N3 בשנת ה- REM
ג. עליה ב- SLEEP EFFICIENCY
ד. שכיחות מוגברת של VIVID DREAMS

44. בן 80, נמצא במעקב מרפאת אי-ספיקת לב. ידוע על מחלת לב אסכמית. עבר אירוע לב לפני כ- 4 שנים, באקו לב תפקוד לב ירוד עם מקטע פליטה של 35%. בבדיקתו: ללא בצקת פריפרית, ללא סימני גודש ריאתי. אשפוז אחרון בעקבות החמרה באי-ספיקת לב לפני מספר חודשים. המטופל מתעניין לגבי פעילות גופנית. מה ההמלצה במצבו?

א. פעילות גופנית יכולה להחמיר תפקוד חדר שמאל ולכן לא מומלצת
ב. פעילות גופנית יכולה לשפר תפקוד ותחושת well being אבל לא משפרת קוצר נשימה
ג. פעילות גופנית יכולה לשפר איכות חיים ולהוריד תמותה
ד. פעילות גופנית מומלצת במצבו היא חיזוק שרירים בלבד ולא פעילות אירובית

45. בת 80, יממה לאחר החלפת מפרק ירך מימין. מהלך הניתוח תקין, ללא סיבוכים. ברקע סובלת מיתר לחץ דם, סוכרת, אי-ספיקת כליות כרונית. בדיקה גופנית תקינה כולל אומדן הערכת דליריום CAM שלילי.

מה ההמלצה בנוגע להתחלת ניידות?

א. עדיף שהמטופלת תשכב במיטה מספר ימים לאחר הניתוח, עד שתרגיש שמסוגלת ללכת

ב. מוביליזציה מוקדמת ככל הניתן, ללא דריכה על הרגל המנותחת

ג. מוביליזציה מוקדמת ככל הניתן, עם דריכה לפי יכולת על הרגל המנותחת

ד. מוביליזציה מוקדמת ככל הניתן, עם דריכה חלקית

46. בן 82, ללא מחלות רקע משמעותיות, עבר ניתוח Radical Prostatectomy. לאחר הניתוח סבל מדימום ממושך מדרכי השתן ונזקק למנת דם. באנמנזה – לא עבר ניתוחים בעברו. ללא דימומים ספונטניים. מדווח על אירוע חד פעמי של דימום לאחר עקירת שן בגיל 30.

בבדיקות המעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
PT (sec)	11.2	10.03-12.43
PT-INR	1.03	0.97-1.19
PTT (sec)	52	25-34
Plt 10e3/µL	354	150-450

מה האבחנה האפשרית?

א. מחלת כבד

ב. DIC (Disseminated Intravascular Coagulation)

ג. חסר של פקטור קרישה XI

ד. תת תזונה עם חסר ויטמין K

47. בן 80, התקבל לשיקום לאחר תיקון שבר בצוואר הירך.

צילום לאחר ניתוח בתמונה 5 .

איזה שבר סביר להניח שהיה לו?

א. שבר אינטרטרוכנטרי

ב. שבר אינטרקפסולרי

ג. שבר אקסטרקפסולרי

ד. שבר סובטרוכנטרי

48. מה מיקום האירוע המוחי שיגרום ל- ABDUCENS PALSY וחולשת גפיים בצד הנגדי?

א. CEREBRAL INFARCTION

ב. MEDULLARY INFARCTION

ג. PONTINE INFARCTION

ד. MIDBRAIN INFARCTION

49. איזה מהבאים הוא היעיל ביותר בהפחתת הסיכון לנפילה בקרב אנשים מבוגרים בקהילה?

א. תכנית אימונים/ התעמלות

ב. תוספת ויטמין D

ג. המלצה על שימוש בעדשות מולטיפוקל לתיקון הפרעות ראיה

ד. הפחתת תרופות המגבירות את הסיכון לנפילה

50. מה שם טכניקת ההערכה בתמונה 6 ?

א. מבחן עמידה מכיסא

ב. בדיקת איזון בת ארבעה שלבים

ג. מדידת מהירות הליכה

ד. מבחן קום ולך

51. איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה נכונה ביותר שינוים בתבנית הליכה בגיל מבוגר?

א. נטייה ל- INTERNAL ROTATION של כף הרגל

ב. שימוש בתנועת הברכיים כפיצוי על הפחתה בתנועת מפרק הירך

ג. השלב בהליכה בו שתי כפות הרגליים נמצאות במגע עם הקרקע מתארך

ד. נטיה לפלקציה של מפרק הקרסול

52. בת 78, ברקע סוכרת, יל"ד, היפרליפידימיה. בחצי שנה האחרונה, מתחילה לסבול מכאבי גב, ללא עדות לפתולוגיה במעבדה או שברים בצילומי רנטגן.

מה באנמנזה יכול להעיד על היצרות התעלה הספינאלית הלומבארית?

א. הכאב מוחמר בישיבה, ומוחמר במעבר משכיבה לישיבה

ב. הכאב מוקל בהליכה במישור בירידה ולא במישור בעלייה

ג. הכאב מקרין לצוואר וגב עליון ולא לרגליים

ד. הכאב מתחיל ברגליים, מלווה בנימול, רדימות, כיווצים ותחושת שריפה

53. בת 84, מתגוררת בגפה, עצמאית בתפקודה, קיימת ירידה קוגניטיבית בשנה האחרונה. לפני שנה ביצעה בדיקת צפיפות עצם עם T SCORE בערך של 1.5- . נוטלת באופן קבוע ויטמין D 1000 יחב"ל וקלציום 600 מ"ג ליממה.
נבדקה במיון עקב נפילה מגובה עמידה במקלחת. נחבלה בחזה ובגב, אובחנו שברים בצלעות ובחוליה L2.
בבדיקות המעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
CREATININE mg/dL	0.7	0.7-1.3
BUN mg/dL	17	5-25
Ca mg/dL	8.9	8.5-10.5
Albumin g/L	36	35-50
Alk Phos U/L	110	46-116
Vitamin D nmol/L	52	> 50

מה הטיפול המומלץ במקרה זה?

א. המשך מתן סידן וויטמין עם הקפדה על היענות לטיפול
ב. BISPHOSPHONATES
ג. TERIPARATIDE (FORTEO)
ד. Hormone Replacement Therapy (HRT)

54. על פי המאמר " Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission", איזה מהטיפולים הבאים הוכח כמפחית סיכון להתפתחות דמנציה ?

א. טיפול בסטטינים למטופלים מבוגרים עם סיכון למחלה וסקולרית
ב. טיפול באספירין (100 מ"ג) למבוגרים בריאים מעל גיל 65
ג. טיפול ביתר לחץ דם
ד. טיפול במעכבי אצטילכולין אסטרז במטופלים עם mild cognitive impairment

55. למי מהמטופלים הבאים יש לבצע בדיקת תרבית שתן למרות שאין לו תלונות מכוונות?

א. מטופל עם פגיעה בעמוד השדרה

ב. דייר במוסד סיעודי

ג. מטופל מושתל כליה לאחר שנה מההשתלה

ד. מטופל לקראת פרוצדורה פולשנית אורולוגית

56. על פי המאמר " Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission", איזה מגורמי הסיכון הבאים ב-Midlife הינו המשמעותי ביותר להתפתחות דמנציה?

א. ירידה בשמיעה

ב. חבלת ראש

ג. יתר לחץ דם

ד. השמנה

57. מה מאפיין SLE (Systemic Lupus Erythematosus) בקשישים לעומת צעירים?

א. השכיחות בגברים קשישים דומה לשכיחות בנשים

ב. ל- ANA בטיטר גבוה סגוליות (SPECIFICITY) גבוהה יותר בקשישים לעומת צעירים

ג. התמונה הקלינית בקשישים סוערת יותר

ד. השכיחות של מעורבות המטולוגית גבוהה יותר בקשישים

58. מטופל הסובל מדמנציה עם קושי ניכר בתפקוד השפתי. המטופל מסוגל להבין משפטים פשוטים, אך לא משפטים מורכבים. קיימת אפרקסיה שפתית. מה סביר למצוא מבחינה פתולוגית?

א. פתולוגיה מסוג TAU

ב. פתולוגיה TDP-43

ג. פגיעה וסקולרית מפושטת

ד. משקעי חלבון 14-3-3

59. במי מהמטופלים הבאים יש מקום לטיפול במעכבי CHOLIESTERASE?

א. מטופל עם תלונות על ירידה בזיכרון, MMSE 24/30, ללא שינוי בתפקודו או באורחות חייו

ב. מטופל הסובל מ- DEMENTIA WITH LEWY BODIES, בדיקת MMSE אחרונה 10/30. כעת עם החמרת הלוצינציות ראיה טורדניות

ג. מטופל עם דמנציה על רקע מחלת אלצהיימר , MMSE 8/30

ד. מטופל עם FRONTOTEMPORAL DEMENTIA, בדיקת MMSE 22/30 , כעת עם החמרה בדיסאינהיביציות

60. בן 97, שמור קוגניטיבית, מתהלך עם הליכון ונזקק לעזרה חלקית ב-ADL, נבדק עקב כאבי עצמות מפושטים ואובחן כסובל מ- CARCINOMA OF PROSTATE עם גרורות לעצמות. PSA-1000.

מה הטיפול המומלץ?

א. ניתוח OPEN PROSTATECTOMY ואחריו טיפול כימותרפי

ב. טיפול ב- LHRH AGONIST

ג. טיפול פליאטיבי בלבד

ד. טיפול כימותרפי במשלב המכיל 5 FU

61. מה מאפיין סימנים של היפרתירואידיזם במבוגרים לעומת צעירים?

א. במבוגרים אין טכיקרדיה

ב. במבוגרים יש בלבול בחלק מהמטופלים

ג. שלשול שכיח במבוגרים יותר מאשר בצעירים

ד. הזעה שכיחה במבוגרים יותר מאשר בצעירים

62. בן 80, לוקה בדמנציה מסוג אלצהיימר, מתגורר בבית אבות. תפקודית – מתהלך עם הליכון, משתתף בפעילות יומיומית בבית אבות. המטופל סובל מאי-שליטה על סוגר שתן המגבילה אותו בפעילות חברתית. לאחרונה הופיעו פצעים שטחיים על רקע רטיבות כרונית באזור פרינאלי.

מה ההמלצה לטיפול?

א. פעילות לשימור ושיפור טונוס שרירי אגן

ב. טיפול תרופתי ב- MIRABEGRON (BETMIGA)

ג. חיבור לפנרוס

ד. ניהול יומן השתנה ולקיחה יזומה לשירותים

63. איזה מהפצעים מתאים לטיפול בחבישות אטומות השומרות על סביבת פצע לחה המאפשרת למאקרופגים ואנזימים לפעול?

א. פצע עם זיהום פעיל

ב. פצע עם רקמה נמקית חלקית

ג. פצע עם תעלות וכיסים

ד. פצע באנשים עם כשל חיסוני

64. מה מהווה אינדיקציה נכונה להשתלת (CARDIOVERTER DEFIBRLLATOR (ICD?

א. מטופל עם EF-35% , NIHA- III, חצי שנה לאחר אוטם שריר הלב

ב. מטופל עם EF-30% , NIHA - IV, שבועיים לאחר אוטם שריר הלב

ג. מטופל עם EF-45%, NIHA- II, חצי שנה לאחר אוטם שריר הלב עם אירוע של VF

ד. מטופל עם EF-25% , NIHA - II , חודש לאחר ניתוח מעקפים

65. בת 84, מתגוררת עם בעלה הסיעודי ומטפלת בו. ברקע ממאירות שד ברמיסיה, סוכרת לא מאוזנת. המטופלת מדווחת על מצב רוח ירוד, חוסר הנאה והפרעות בשינה.
איזה מהגורמים הבאים מעלה את הסיכון לאובדנות במטופלת זו?

א. סוכרת לא מאוזנת

ב. הפרעות בשינה

ג. מין נקבה

ד. הטיפול בבעלה הסיעודי

66. איזה מהמשפטים הבאים נכון בנוגע לאפידמיולוגיה של דלירום במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) ?

א. HYPERACTIVE DELIRIUIM יותר שכיח מ HYPOACTIVE DELIRIUM

ב. קיים קשר בין הופעת דלירים לבין דכאון אחרי שחרור מבית חולים

ג. דלירים יותר שכיח בנשים לעומת גברים

ד. מעל 50% מהמטופלים מעל גיל 65 סובלים מדלירים במהלך שהותם במלר"ד

. מה מתאר בצורה נכונה את השינויים הפיזיולוגים בהזדקנות הריאה?

א. FORCED EXPIRATORY VOLUME IN 1 SECOND (FEV1) יורד

ב. DIFFUSION CAPACOTY FOR CARBON MONOXIDE (DLCO) לא משתנה

ג. FORCED VITAL CAPACITY (FVC) עולה

ד. RESIDUAL VOLUME (RV) יורד

68. בן 75, ברקע מחלת לב איסכמית, אי-ספיקת כליות עם GFR של 45 מ"ל/דקה, אירוע של CVA בעבר. במעבדה – המוגלובין A1C – 8.9%.

לאיזו מהתרופות הבאות לסוכרת יש פוטנציאל להביא לשינוי פרוגנוסטי למחלות הרקע?

א. משפחת GLP1 להורדת תסמיני אי-ספיקת לב

ב. משפחת מעכבי SGLT2 לצורך הגנה כלייתית

ג. METFORMIN כמניעה שניונית לשבץ

ד. משפחת DPP4 למחלת לב איסכמית

69. איזו מהבדיקות הבאות היא מנבא סיכון מתוקף לנפילה אצל קשישים?

א. מבחן TIMED UP AND GO

ב. מדד BBARTHEL

ג. אומדן FIM

ד. FRAILTY לפי FRIED

70. בן 75, שמור קוגניטיבית ועצמאי בתפקודו, סובל מסוכרת מאז גיל 50. ברקע מחלת לב איסכמית עם סטנט ל-LAD לפני כעשור ואי-ספיקת כליות כרונית עם GFR של 52 מ"ל/דקה. המטופל שוקל 80 ק"ג (BMI 28).

תרופות: INSULIN LANTUS 18 units+ APIDRA 6 units X3 , RAMIPRIL, ATORVASTATIN, METFORMIN, ASPIRIN, EMPAGLYFLOZIN.

במעבדה:

פאנל שומנים בדם- LDL 68, HDL 34, Triglycerides 124

המוגלובין A1C- 7.0

יחס אלבומין-קריאטינין 357

על פי המאמר ADA Older Adults: Standards of Medical Care in Diabetes-2022

איזה מבין השינויים התרופתיים הבאים יועיל למטופל?

א. הפסקת הטיפול בסטטינים בשל פינוי כלייתי לקוי ושינוי לטיפול ב-BEZAFIBRATE

ב. הפסקת טיפול ב-METFORMIN מחשש לחמצת לקטית

ג. הפסקת טיפול ב- EMPAGLYFLOZIN בגלל אי-ספיקת כליות

ד. החלפת הטיפול ב- INSULIN APIDRA לטיפול ב- SITGALIPTIN (JANUVIA)

71. איזה מהבאים מה מהווה גורם מזרז (Precipitating Factor) לדליריום?

א. דכאון

ב. ליקוי תפקודי

ג. רמת אלבומין נמוכה

ד. מחלת רקע חמורה

72. איזה מהבאים מייצג גישה טיפולית נכונה בחולה הסובל מ- COPD ומירידה קוגניטיבית?

א. לחולה שלא מצליח למלא הוראות, שיש לו מטפל צמוד ובעל PEAK INSPIRATORY FLOW נמוך מתאים להשתמש ב- NEBULIZER

ב. לחולה שלא מצליח למלא הוראות ובעל PEAK INSPIRATORY FLOW גבוה מתאים להשתמש ב- DPI (DRY POWDER INHALER)

ג. לחולה שלא מצליח למלא הוראות, שאין לו מטפל צמוד ובעל PEAK INSPIRATORY FLOW נמוך מתאים להשתמש במשאף עם SPACER

ד. לחולה שמצליח למלא הוראות, אין לו מטפל צמוד ובעל PEAK INSPIRATORY FLOW נמוך מתאים להשתמש ב- DPI (DRY POWDER INHALER)

73. איזה מהבאים הוא התערבות למניעת דליריום לאחר שבר צוואר הירך?

א. איזון כאב אגרסיבי על ידי מינונים גבוהים של אופיואידים

ב. פיזיותרפיה לניוד מוקדם לאחר הניתוח

ג. מעקב סימנים חיוניים קפדני על ידי מוניטור

ד. עירוי דם לשמירת המטוקריט מעל 40%

74. איזה מהבאים נכון לגבי יעילות טיפול בחולים זקנים עם אי ספיקת לב עם ירידה במקטע הפליטה (HFrEF)?

א. חיסון נגד שפעת הוכח כמפחית תמותה

ב. מעכבי SGLT2 יעילים בהפחתת תמותה בצעירים אך לא בזקנים

ג. טיפול במשתנים הוכח כמפחית סימפטומים של גודש ריאתי ובצקות, וכן כמפחית תמותה

ד. חוסמי בטא הוכחו כמונעים אשפוזים, אך יש קונטראינדיקציה יחסית בזקנים

75. מהי תופעת לוואי אפשרית של טיפול כרוני בקורטיקוסטרואידים בשאיפה בחולה COPD?

א. Contact Dermatitis בכפות הידיים

ב. אוסטאופורוזיס

ג. אאוזינופיליה

ד. כיבים במערכת העיכול

76. מה מאפיין שבץ מוחי המערב את הטריטוריה של Anterior Cerebral Artery-ACA?

א. מתבטא בשיתוק רפוי (פלצידי) של כף היד

ב. מתבטא בפגיעה ברגל יותר מאשר פגיעה ביד

ג. לא משפיע על מתן שתן

ד. נגרם לרוב כתוצאה ממחלה אטרוסקלרוטית ולא מתסחיף

77. בת 75, מתגוררת בדיור מוגן, מתניידת עם הליכון, לוקה בדמנציה, תחת טיפול ב- MEMANTINE. מתקבלת לאשפוז במחלקה פנימית בשל דלקת ריאות ומקבלת טיפול אנטיביוטי ב- CEFTRIAXONE וטיפול מניעתי ב- OMEPRAZOL ו-ENOXAPARIN. לשינה טופלה ב- ZOLPIDEM.

ביום השני לאשפוזה החולה מבולבלת, באי שקט ניכר וצועקת. בשיחה איתה, נראה כי היא חושבת שהיא נמצאת כעת בביתה.

איזה טיפול תרופתי יכול לגרום למצבה בסבירות הגבוהה ביותר?

א. ZOLPIDEM

ב. OMEPRAZOLE

ג. MEMANTINE

ד. CEFTRIAXONE

78. בן 70, אובחן עם תסמונת Guillain-Barré ואושפז באופן דחוף בטיפול נמרץ עקב שיתוק מתקדם ואי-ספיקה נשימתית.

איזה מהטיפולים הבאים, אם יינתן מוקדם, עשוי לקצר את מהלך המחלה ולהפחית את השכיחות של שיתוק קבוע?

א. עירוי פלסמה

ב. קורטיקוסטרואידים

ג. IVIG

ד. CYCLOPHOSPHAMIDE

79. מטופל הסובל מדמנציה ומטופל ב- RIVASTIGMINE (EXELON) החל לאחרונה לסבול מבעיות בשליטה במתן שתן. מה מומלץ במצב זה?

א. לשקול להפסיק את הטיפול ב- RIVASTIGMINE

ב. להתחיל טיפול אנטימוסקריני, כמו FESOTERODINE (TOVIAZ)

ג. להתחיל טיפול ב – MIRABEGRON (BETMIGA)

ד. להפנות לבדיקה אורודינמית לברור אי-שליטה

80. בן 68, סובל מאיטיות מוטורית ורעד במנוחה שהחלו לפני מספר חודשים.

איזה מהבאים תומך בכך שסובל ממחלת פרקינסון אידיופטית?

א. קיימים נוקשות ורעד סימטריים

ב. ישנה תגובה מינימלית לטיפול ב- Levodopa אשר ניתן על ידי רופא המשפחה

ג. ברדיקינזיה והפרעה בהחזרים הפוסטוראלים

ד. הפרעה בתנועות עיניים כלפי מטה

81. בן 84, הופנה להערכה בחשד לדמנציה.

המשפחה מדווחת על ירידה בזיכרון, קשיים בתפקוד יומיומי, הליכה איטית והפרעות בשינה.

בבדיקת MMSE על ידי רופא המשפחה קיבל ציון 18/30.

בהערכה במרפאה בוצע MMSE עם ציון 23/30. בהערכות נוספות CAM שלילי, GDS-15 ציון 2. ללא חסר נוירולוגי פוקלי נוסף. בוצע CT ראש שלא הדגים מחלה צרברו-וסקולרית.

מה יכול להסביר את ההבדל בין שתי בדיקות MMSE שביצע?

א. צפויים הבדלים גדולים בבדיקת ה- MMSE בין בודקים שונים

ב. דליריום הינו הסבר סביר להבדלים

ג. בדמנציה על רקע מחלת אלצהיימר יתכנו פלוקטואציות

ד. בדמנציה על רקע מחלת גופיפי לוי (LBD) יתכנו פלוקטואציות

82. בת 74. לוקה בדמנציה. מאושפזת במחלקה הפנימית בשל החמרה באי-ספיקת הלב משנית לאי לקיחת טיפול תרופתי. העובדת הסוציאלית מדווחת כי המטופלת מתגוררת עם בנה הגרוש, שמוכר כמטפל הרשמי שלה מטעם חוק סיעוד. במהלך האשפוז הבן לא הגיע כלל למחלקה. לקראת השחרור המטופלת מבקשת לחזור לביתה.

מה יהיה השלב הבא בתכנית השחרור של המטופלת?

א. יש למנות עבורה אפוטרופוס שידאג לכל צרכיה

ב. לקבל את הסכמתה לפנות לפקידת סעד

ג. לכבד את רצונה של המטופלת ולשחררה לביתה

ד. לדווח לפקידת סעד ולא לשחרר עד למציאת פתרון הולם

83. מה המנגנון <u>השכיח ביותר</u> של תעוקת חזה בחולה זקן עם היצרות אאורטלית?

א. מחלה קורונרית

ב. איסכמיה סב-אנדוקרדיאלית

ג. חוסר התאמה בין ה- CARDIAC OUTPUT לצרכים

ד. פרפור עליות

84. בן 91, סובל מממאירות ריאה עם גרורות לעצמות, לכבד ולמוח. האונקולוגים החליטו להפסיק טיפולים כימותרפיים והמליצו על טיפול פליאטיבי בלבד. החולה מאושפז כרגע במחלקה פנימית בשל דלקת בדרכי השתן.

מי מוסמך להיות "הרופא האחראי" ולהגדיר את החולה כנוטה למות?

א. הרופא האונקולוג המומחה המטפל

ב. כל רופא אונקולוג מומחה

ג. מנהל המחלקה הפנימית

ד. כל רופא מומחה במחלקה הפנימית

85. איזו תשלובת חיסונים מומלצת לחולה COPD בן 80 בנוסף לחסון נגד שפעת?

א. PNEUMOVAX ו- PCV13 חד פעמי

ב. PNEUMOVAX <u>או</u> PCV13 כל חמש שנים

ג. PNEUMOVAX <u>ו</u>- PCV13 כל חמש שנים

ד. PNEUMOVAX <u>ו</u>- PCV13 כל חמש שנים, חיסון ל- HAEMOPHILUS INFLUENZA חד פעמי

86. איזה מהבאים נכון בנוגע לסמכות הרפואית הנדרשת להגדרת הסטטוס התפקודי המפורט במשפטים שלהלן?

א. מומחה ברפואה פנימית יכול לאשר סטטוס סיעודי מורכב וסטטוס סיעודי

ב. גריאטר מחוזי צריך לאשר סטטוס סיעודי או תשוש נפש אם זקוקים ל"קוד"

ג. סטטוס שיקומי מאושר רק על-ידי גריאטר

ד. סטטוס מונשם כרוני מאושר על-ידי גריאטר או רופא ריאות

87. בן 88, סובל מדמנציה מתקדמת, מרותק למיטה עם פצעי לחץ דרגה 4. בבדיקות המעבדה עליית קריאטינין ל-8 והועלתה שאלה של טיפול בדיאליזה. לחולה בת אחת מסורה שאומרת שאביה היה מעוניין להימנע מדיאליזה במצב זה.

כיצד מתקבלת החלטה על המשך הטיפול?

א. יש להתחיל בדיאליזה עם חתימה של 3 רופאים

ב. מומלץ מינוי אפוטרופוס דחוף שיחתום על הימנעות מדיאליזה

ג. יש להגדירו כחולה הנוטה למות ולהיעזר בתצהיר אדם קרוב לקבלת ההחלטה

ד. ניתן להימנע מדיאליזה רק אם החולה מילא הנחיות מקדימות

88. בן 82, ברקע עישון כבד, סובל מעודף משקל. התקבל עקב קוצר נשימה ובצקת ברגליים.

ברקע: אי ספיקת כליות. בבדיקת דם: המוגלובין 17.

בבדיקה: BNP מוגבר.

איזה מהגורמים הבאים יכול לגרום לעליה ב- BNP?

א. מין זכר

ב. עודף משקל

ג. אי ספיקה כלייתית

ד. פוליציטמיה

89. בת 92, מאושפזת במחלקה נוירולוגית לאחר אירוע מוחי עם פלגיה מלאה מימין.

מה מהבאים מהווה קונטראינדיקציה להפנותה לאשפוז שיקומי?

א. חוסר שיתוף פעולה בטיפול

ב. הפרעות בליעה המצריכות הזנה בזונדה

ג. פצע לחץ דרגה 4 בעקב ימין

ד. אפזיה מוטורית

90. בן 75, מאושפז במחלקה לתשושי נפש. לאחרונה סבל מאצירת שתן, הוכנס צנתר לדרכי השתן, הוחל טיפול ב-DUODART וזקוק לביקור אצל אורולוג לצורך החלטה על גמילה או ניתוח.

מה חלוקת הסמכויות בין הגופים בטיפול בחולה זה?

א. קופת החולים מממנת את התרופה, שקיות השתן והביקור אצל האורולוג

ב. המוסד מממן את התרופה ושקיות השתן ומזמין על חשבונו ביקור של אורולוג

ג. המשפחה קונה את התרופה ושקיות השתן וקופת החולים מממנת את הביקור אצל האורולוג

ד. קופת החולים מממנת את התרופה ושקיות השתן והמשפחה מממנת את הביקור אצל האורולוג

91. בן 65 נבדק במרפאה גריאטרית ונמצא סובל מדמנציה עם MMSE 21/30, התנהגות פרונטלית והפרעה בשיפוט. החולה בעל משאית ונוהג, לדבריו ללא כל מגבלה. הוסבר לו שעליו להימנע מנהיגה אך הוא מסרב.

מה יש לעשות בנושא?

א. לדווח לחברת המשאיות שמעסיקה אותו

ב. לדווח למרכז הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד)

ג. לדווח לרופא המשפחה שלו כדי שלא יחתום לו על אישור לחידוש רישיון נהיגה

ד. עקב סודיות רפואית לא ניתן להעביר דיווח ללא הסכמת המטופל

92. מה מאפיין את תוחלת החיים בישראל על פי לקט הנתונים של מכון ברוקדייל?

א. תוחלת החיים של גברים יציבה ב- 40 השנים האחרונות

ב. תוחלת החיים בנשים גבוהה ב-4 שנים מגברים

ג. ישראל היא השנייה בעולם בתוחלת החיים אחרי יפן

ד. תוחלת החיים של נשים עלתה ב-10 שנים מאז 1995

93. בן 62, סובל מדמנציה שהתפחתה באופן מהיר. הדמנציה מתבטאת בירידה ביכולת פתרון בעיות, ירידה לא ספציפית בזיכרון, כאשר יכולת השפה שמורה.

בחשד למחלת פריונים (PRION DISEASE), מה סביר למצוא בבדיקה נוירולוגית?

א. סימני צד

ב. החזרים מוגברים

ג. רעד

ד. סימני שחרור פרונטליים

94. בן 80 פנה למחלקה לרפואה דחופה עקב דלקת ריאות. בקבלתו חום 38.6, דופק 115, לחץ דם 80/40, נשימות 32, סטורציה 88% באוויר חדר. בשעות הראשונות היה ישנוני ומבולבל. טופל ב- IV CEFTRIAXONE, IV ACAMOL ועירוי נוזלים והשתפר. החום ירד. החולה מבקש להשתחרר לטיפול בביתו.

מה הטיפול המומלץ על פי המדד הפרוגנוסטי CURB-65 ?

א. במידה ויכול לשתות מספיק ולבלוע אנטיביוטיקה יכול להמשיך בטיפול בביתו

ב. מדובר במחלה עם סיכון גבוה לתמותה והטיפול הנכון הוא באשפוז

ג. חסר נתון של BUN בקבלה ולכן לא ניתן להעריך אם מתאים לטיפול באשפוז או בבית

ד. צריך לקבל אנטיביוטיקה IV , אך יכול לקבלה במסגרת אשפוז בית

בשאלות הבאות יש לסמן את התשובה הלא נכונה:

95. איזו שאלה מהשאלות הבאות לא נכללת במבחן ה- AMT-4 (Abbreviated Mental Test-4).

א. בן כמה אתה?

ב. מה תאריך הלידה שלך?

ג. באיזו שנה אנחנו?

ד. מה שמך?

96. כל התרופות הבאות הוכחו כמפחיתות אשפוזים בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד פרט לאחת.

איזו מהתרופות הבאות לא מפחיתה אשפוזים בחולים אלה?

א. SPIRONOLACTONE

ב. CANDESARTAN

ג. ATENOLOL

ד. EMPAGLIFLOZIN

97. איזה מהמצבים הבאים לא מהווה אינדיקציה להחלפת מסתם אאורטלי ?

א. EF = 60%, שטח מסתם = 0.8 ס"מ^2 ומפל לחצים של 45 מ"מ כספית במטופלת עם תלונות על כאבים בחזה

ב. EF = 40%, שטח מסתם = 0.9 ס"מ^2 ומפל לחצים של 45 מ"מ כספית במטופלת א-תסמינית

ג. EF = 55%, שטח מסתם = 0.7 ס"מ^2 ומפל לחצים של 45 מ"מ כספית במטופלת א-תסמינית שמתוכננת לניתוח CABG

ד. EF = 55%, שטח מסתם = 0.8 ס"מ^2 ומפל לחצים של 45 מ"מ כספית במטופלת א-תסמינית

98. בן 83, מתגורר במחלקה סיעודית. ברקע סובל מ-COPD, יתר לחץ דם, דמנציה מסוג אלצהיימר בדרגת חומרה קלה ושבריריות בולטת.

המטופל נוטל את התרופות הבאות:

AMLODIPINE 10 mg x 1

FUROSEMIDE 40 mg x 1

RISPERDONE 1 mg X2

DOPICAR 1 tab x 3

ASPIRIN 100 mg x1

DONEPAZIL 10 mg x1

FESOTERODINE 8 mg x1

משאפים לטיפול כרוני ב-COPD.

בבדיקה- לחץ דם 150/80, דופק סדיר 82, בצקת פריפרית בקרסוליים אבל ללא סימנים נוספים לאי-ספיקת לב. בבדיקה נוירולוגית- ברדיקינזיה וריגידיות.

כל הבאים הם קסקדה טיפולית פרט לאחד.

איזה שילוב תרופות <u>לא</u> מהווה קסקדה טיפולית?

א. RISPERDONE ו- DOPICAR

ב. DONEPEZIL ו- TOVIAZ

ג. AMLODIPINE ו- FUSID

ד. DOPICAR ו- FUSID

99. כל המשפטים הבאים לגבי מעכבי Cholinesterase נכונים פרט לאחד.

איזה מהמשפטים הבאים <u>לא נכון</u> לגבי קבוצת התרופות ?

א. ניתן להקל על הפרעות השינה על ידי נטילת התרופה בבוקר

ב. תופעות הלוואי השכיחות הינן בחילות, אנורקסיה ושלשולים

ג. מומלץ להתחיל טיפול במינון נמוך ולהעלות מינון כל חודשיים עד הגעה למינון טיפולי

ד. ניתן להקל על תופעות הלוואי הגסטרואינטסטינליות על ידי נטילה על בטן ריקה

100. איזה מהבאים לא נכלל בקריטריונים של FRIED ל-FRAILTY ?

א. ירידה לא מתוכננת במשקל

ב. הליכה איטית

ג. יותר משתי נפילות בחצי שנה

ד. תשישות סובייקטיבית (EXHAUSTION)

101. בן 84 אושפז עקב ספסיס ו- HYPEROSMOLAR COMA.

בבדיקות המעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	144	135-146
K mmol/L	5.2	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	1.8	0.7-1.3
BUN mg/dL	54	5-25
CA mg/dL	7.8	8.5-10.5
GLUCOSE mg/dL	452	70-110
Albumin g/dL	2.1	3.5-5.0
CRP mg/L	250	<0.03-5

מה הערכים המתוקנים של NA ו- CA?

א. CA מתוקן 9.4 NA מתוקן 151

ב. CA מתוקן 10.8 NA מתוקן 151

ג. CA מתוקן 10.8 NA מתוקן 128

ד. CA מתוקן 9.4 NA מתוקן 128

102. בת 85, דיירת מחלקה סיעודית אושפזה במחלקה פנימית עקב דלקת ריאות. באנמנזה מול המחלקה הסיעודית מתברר שסבלה מזיהום ב- INFLUENZA שבועיים טרם אשפוזה.

מה המחולל הנשימתי השכיח במצב זה?

א. STREPTOCOCUS PNEUMONIA

ב. HEAMOPHILUS INFLUENZA

ג. STAPH AUREUS

ד. PNEUMOCYSTIS CARINII

103. איזה מהבאים הוכח כמפחית אשפוזים לחולה COPD?

א. תרופות נוגדות חרדה כמו בנזודיאזפינים

ב. חמצן אם הסטורציה מתחת ל- 93%

ג. טיפול ב-alpha-AT augmentation

ד. שיקום נשימתי

104. מה מהבאים מאפיין מצב של מוות מוחי?

א. אישונים צרים PIN POINT

ב. נשימות ספונטניות מתחת ל- 8 לדקה

ג. היעדר CORNEAL REFLEX

ד. ברדיקרדיה מתחת ל- 45

105. בן 75, ברקע אי-ספיקת לב ויתר לחץ דם. מטופל ב- ASPIRIN, AMIODARONE, DISOTHIAZIDE ו- AMLODIPINE אושפז בשל חולשה כללית.

אק"ג ראו תמונה 7 .

מה ההפרעה האלקטרוליטרית המתאימה לפי האק"ג?

א. היפוקלמיה

ב.היפונתרמיה

ג. היפרמגנזמיה

ד.היפרקלצמיה

106 מה מאפיין את ההסתמנות הקלינית של POLYMYALGIA RHEUMATICA?

א. חום סוב פיברילי

ב. כאב לא סימטרי

ג. מעורבות חגורת הכתפיים שכיחה יותר מהאגן

ד. מיופתיה דיסטלית

107 . בן 91 אסימפטומטי עבר בדיקת אקו לב שהדגימה היצרות אאורטלית 0.8 ס"מ, ללא הפרעה אזורית בהתכווצות הלב.

מה אופייני לממצאים הקליניים של הפרעה זו?

א. בחלק מהחולים יש אנמיה משנת לחסר ויטמין B12

ב. בהאזנה ללב מעבר לאוושה אופייני קול שלישי

ג. בשכיחות גבוהה יש באק"ג עדות ל LV hypertrophy

ד. ככל שהמחלה מתקדמת, צפוי כי ה- PULSE PRESSURE של החולה יהיה גדול יותר

108. בת 75 פנתה לברור כאבי ראש. היא מתארת שהכאב הופיע באופן פתאומי (תוך דקות) לפני כשבוע, בעל אופי שורף, מוחמר בבוקר, מלווה ברגישות ניכרת במגע בקרקפת. הועלתה אבחנה אפשרית של TEMPORAL ARTERITIS.

מה מכל מאפייני הכאב של המטופלת מתאים לאבחנה של TEMPORAL ARTERITIS?

א. הופעה תוך דקות

ב. אופי שורף

ג. רגישות במגע בקרקפת

ד. כאב שמוחמר בבוקר

109. איזו מהפרעות הקרישה הבאות תגרום להארכה של PT ללא השפעה על PTT?

א. חסר פקטור VII

ב. חסר פקטור XIII

ג. הטרוזיגוטיות ל- FACTOR V LEIDEN

ד. VON WILEBRAND DISEASE

110. בת 78, ברקע: פרפור פרוזדורים, מטופלת ב- NOAC, אי ספיקת לב דיאסטולית, יתר לחץ דם וסוכרת. נבדקה במחלקה לרפואה דחופה עקב חום וצריבה במתן שתן. הוחל טיפול באנטיביוטיקה ונוזלים. לאחר שעתיים התלוננה על קוצר נשימה. סימנים חיוניים: חום 39, דופק 120, לחץ דם 110/80 , סטורציה 83%.

צילום חזה – ראו תמונה 8 .

מה האבחנה והטיפול המתאים?

א. יש לחשוד בתסחיף ריאתי. מומלץ להשלים CTA ובינתיים לעבור לטיפול ב- CLEXAN

ב. מדובר ב-acute respiratory distress syndrome (ARDS) משני לספסיס ומומלץ להוסיף טיפול בסטרואידים

ג. לא ניתן לשלול דלקת ריאות ולכן מומלץ טיפול אנטיביוטי רחב טווח שיכסה גם זיהום בדרכי השתן וגם דלקת ריאות

ד. מדובר בגודש ריאתי ומומלץ טיפול ב- FUSID

111. בן 80, ברקע ממאירות קולון, מטופל בכימותרפיה דרך פיקליין. אושפז עם חום 39, ולחצי דם נמוכים 80/50. בבדיקות דם - נויטרופילים 400. בשתי תרביות דם - אחת מדם פריפרי ואחת מהפיקליין - צמיחה של Staphylococcus coagulase-negative .

כיצד מומלץ לטפל?

א. עקב נויטרפניה מומלץ לתת טיפול דרך הפיקליין ב- TAZOCIN

ב. מומלץ להוציא את הפיקליין ולתת טיפול ב- VANCOMYCIN

ג. מומלץ להוציא את הפיקליין, לאור נויטרופניה יש להימנע מטיפול ב- VANCOMYCIN

ד. מומלץ להשאיר את הפיקליין לספיגה מירבית ולתת טיפול רחב טווח ב- AUGMENTIN ו- CIPROFLOXACIN

112. בן 84, מאושפז לבירור חום 38-38.5 מזה 3 שבועות. מתלונן על חולשה, ללא כאבי פרקים, ללא שיעול, ללא שינוי בהרגלי יציאה. שולל חשיפה למחלות זיהומיות אטיפיות. בדיקה גופנית ללא ממצא משמעותי.

בדיקות הדם:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	138	135-146
K mmol/L	4.8	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	1.1	0.7-1.3
BUN mg/dL	28	5-25
AST (GOT) U/L	42	<7-40
ALT (GPT) U/L	34	<7-35
ALK PHOS U/L	118	46-116
LDH U/L	352	208-378
ALBUMIN g/dL	3.9	3.5-5.0
WBC 10e3/µL	5.8	4.0-11.0
HgB g/dL	12.9	13.2-17 גבר
Plt 10e3/µL	187	150-450
CRP mg/L	84	<0.03-5

CT חזה ובטן ללא ממצא. פנל בדיקות ראומטי ללא ממצא. מנטו שלילי. תרביות דם ושתן שליליות.

מה השלב הבא בבירור?

א. ביופסיית מח עצם

ב. ביופסיית כבד

ג. ביופסיית עורק טמפורלי

ד. ביופסיית עור

113. איזה מהבאים מתאר קשר נכון בין אתר הפעולה לבין הטיפול הביולוגי?

א. MITOTIC SPINDLE – TRASTUZUMAB (HERCEPTIN)

ב. CYTOCHROME C – BEVACIZUMAB (AVASTIN)

ג. BCR-ABL TYROSINE KINASE - IMATINIB (GLIVEC)

ד. T CELL RECEPTOR - LENALIDOMIDE

114. מה ההבדל בין Diabetic Ketoacidosis (DKA) לבין Hyperosmolar Hyperglycemic State (HHS) בזקנים?

א. המרכיב של החמצת משנית לגופי הקטון גדול יותר ב- HHS

ב. המרכיב של ההתייבשות הוא משמעותי יותר ב-HHS ומשנית לכך פגיעה כלייתית

ג. האטיולוגיה של HHS בניגוד ל-DKA היא בעיקר של חוסר באינסולין שמוביל לליפוליזה ולחמצת

ד. בקשישים שברירים בני 80 ומעלה DKA שכיח יותר מ- HHS

115. בן 84, התקבל לאשפוז עקב דלקת ריאות. בקבלתו למחלקה – מעורפל הכרה, טכיפנאי, לחץ דם נמוך. שבועיים טרם אשפוזו שוחרר מאשפוז של חודש עקב שלשול משני ל- CLOSTRIDIUM DIFFICILE. כעת לא משלשל.

מה הטיפול האנטיביוטי המומלץ?

א. PO METRONIDAZOLE + IV CEFTRIAXONE

ב. PO VANCOMYCIN + IV VANCOMYCIN + IV TAZOCIN

ג. IV VANCOMYCIN + IV TAZOCIN

ד. PO VANCOMYCIN + IV CEFTRIAXONE

116. בן 80 סובל מאי ספיקה כלייתית עם קריאטינין 6. מה סביר שימצא במשטח דם?

א. BURR CELLS

ב. RETICULOCYTOSIS

ג. TARGET CELLS

ד. HOWELL-JOLLY BODIES

117. בת 86, ברקע: סוכרת מטופלת ב- METFORMIN, יתר לחץ דם מטופל בחוסמי ACE. מתלוננת על סחרחורת, דפיקות לב ושני אירועים של פרה-עילפון בשבוע האחרון. כעת מרגישה טוב ויציבה המודינמית.

תרשים אק"ג המשכי - ראו תמונה 9 .

מה האבחנה ומה הטיפול המומלץ?

א. סינוס טכיקרדיה עם APB'S מרובים, לאחריהן פאוזות קומפנסטוריות, אחת ארוכה במיוחד. מומלץ טיפול בחוסמי בטא והפניה לאלקטרופיזיולוג

ב. High degree AV Block. יש צורך בהשתלת CRTD

ג. פרפור פרוזדורים עם העברה חדרית משתנה. מומלץ TEE והיפוך תרופתי או חשמלי

ד. Sinus node dysfunction (SND). מומלצת השתלת קוצב

118. איזו מהתרופות הבאות יכולה לגרום לעליה ברמת PROLACTIN ?

א. RISPERIDONE

ב. LERCANIDIPINE

ג. ALENDRONATE

ד. CLINDAMYCIN

119. איזה מהסימפטומים הבאים יכול להיות מוסבר בעקבות PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM?

א. חולשת שרירים דיסטלית

ב. ירידה קוגניטיבית

ג. כאבים בחזה

ד. שלשול

120. כל החולים שלהלן סובלים מפרפור עליות כרוני. באיזה מהמשפטים הבאים ניתן טיפול מתאים למצב המתואר?

א. APIXABAN - לבן 85 עם סוכרת והיצרות קשה של המסתם האאורטלי

ב. DABIGATRAN - לבת 78 חולת דיאליזה עם נוירופתיה וסוכרת

ג. RIVAROXABAN - לבן 75 עם יתר לחץ דם ומסתם אאורטלי מכני

ד. EDOXABAN - לבת 87 עם אירוע מוחי איסכמי לפני שנתיים והיצרות קשה של המסתם המיטרלי

121. בת 77, בעברה ללא אי ספיקה כלייתית.

אושפזה עקב פיילונפריטיס עם בקטרמיה, מטופלת ב- TAZOCIN, יום 3 לטיפול. בבדיקתה ערנית ומשתפת פעולה, לחץ דם 110/75, דופק 110, סטורציה תקינה באוויר חדר, חום 38.2.

בבדיקות הדם:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	141	135-146
K mmol/L	4.6	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	1.7	0.7-1.3
BUN mg/dL	56	5-25
WBC 10e3/µL	22,500	4.0-11.0
HgB g/dL	11.2	אשה 11.7-15.5
Plt 10e3/µL	388	150-450

CT פרוטוקול אבנים - ללא עדות להידרונפרוזיס או אבצס. נשללה אצירת שתן.

מה הסיבה הסבירה ביותר לאי ספיקת כליות החריפה?

א. היפוולמיה

ב. Acute Tubular Necrosis (ATN)

ג. Interstitial Nephritis על רקע הטיפול ב- TAZOCIN

ד. CT פרוטוקול אבנים

122. בת 79 אושפזה עקב קוצר נשימה.

בקבלתה סטורציה 86% ותוקנה ל-95% עם מסיכת חמצן 100% . בדיקת PCO_2 – 35 (תקין 40-51).

מה קרוב לודאי המנגנון הפיזיולוגי הגורם להיפוקסיה?

א. VENTILATION PERFUSION MISMATCH

ב. RIGHT TO LEFT SHUNTING

ג. HYPOVENTILATION

ד. ANEMIA

123. בן 82, עצמאי בתפקודו ושמור קוגניטיבית, בריא בדרך כלל ולא מעשן. סובל בחודשים האחרונים מאירועים של לחץ בחזה, המתרחש לאחר מאמץ גופני, ומוקל מיד במנוחה. הכאב מופיע בעליה של 3 קומות במדרגות או הליכה של 10 דקות. אק"ג במנוחה ללא ממצא חריג.
מה מהבאים הוא השלב הבא המתאים ביותר לאבחון?

א. CARDIOVASCULAR COMPUTERED TOMOGRAPHY (CCTA)
ב. צינתור עורקים כליליים
ג. מבחן מאמץ
ד. מיפוי לב עם דיפירידמול

124. איזה מהבאים מתאר קשר נכון בין מוטציה לבין הממאירות ההמטולוגית הקשורה אליה?

א. T8,14 –BURKITT LYMPHOMA
ב. P53 – CHRONIC MYELOGENOUS LEUKEMIA
ג. BCR-ABL – ACUTE LYMPHATIC LEUKEMIA
ד. C-MYC – MULTIPLE MYELOMA

125. מי מהמטופלים הבאים עם אי ספיקה כלייתית חדה זקוק לדיאליזה דחופה?

א. בן 83, עם בצקת ריאות ואנסרקה ללא תגובה ל- FUSID
ב. בן 79, עם קריטיאנין 6.7 ו- BUN- 132
ג. בת 85, עם 7.2-PH ו- BICARBONATE -12
ד. בת 74, גרד קשה ללא תגובה לאנטיהיסטמינים

126. מה מתאר נכון אטיולוגיה של זיהומים בדרכי השתן בקשישים?

א. בנשים עצמאיות עם בקטריאוריה אסימפטומטית תהיה ברוב המקרים צמיחה מעורבת
ב. בקשישים במוסדות הגורם השכיח ביותר לזיהום בדרכי השתן הוא Enterococcus
ג. זיהום בדרכי השתן על ידי methicillin-resistant S aureus (MRSA) יכול להיות משני לבקטרמיה ממקור אחר
ד. בנשאים של קתטר קבוע רוב הזיהומים הם פולימיקרוביאלים

127. בת 85, בדרך כלל בריאה ולא נוטלת תרופות. הגיעה לבירור עקב מדידות חוזרות של לחץ דם סביב 150/110.

איזו מהבדיקות הבאות מומלצת כחלק מהבירור?

א. דופלקס עורקי הכליה

ב. איסוף שתן לקטכולאמינים

ג. בדיקת שינה

ד. DEXAMETASONE SUPPRESION TEST

128. בת 68 , עצמאית ושמורה קוגניטיבית, ללא מחלות רקע משמעותיות, אובחנה כסובלת מיתר לחץ דם עם ערכים סביב 135/85.

מה הגישה הטיפולית הנכונה?

א. התחלת טיפול תרופתי ב- HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg X1

ב. התחלת טיפול תרופתי ב- RAMIPRIL 1.25 mg X1

ג. טיפול לא תרופתי כולל ירידה במשקל, פעילות גופנית ודיאטה דלת מלח

ד. מעקב לחץ דם אחת לחודש

129. בן 70, ללא רקע של עישון , וללא סימפטומים של ירידה במשקל התקבל לאשפוז בשל המופטיזיס בכמות של 120 מ"ל ב-24 שעות. בבדיקתו במחלקה מדדים תקינים. המוגלובין תקין, וצילום חזה תקין.

מה תכנית הבירור המומלצת ומדוע?

א. כיוון שמדובר בכמות של מעל 100 מ"ל ב-24 שעות מדובר בהמופטיזיס מסכן חיים ויש להפנות לברונכוסקופיה דחופה

ב. מכיוון שאינו מעשן וצילום חזה תקין אין צורך בהמשך ברור

ג. רוב המקרים של המופטיזיס בכמות קטנה, מומלץ מעקב כל חצי שנה

ד. מומלץ להתקדם לבדיקת CT חזה

130. בת 85, מתלוננת על קוצר נשימה מזה מספר חודשים. השלימה תפקודי נשימה:
TLC=100%, FRC= 104%, RV= 95%, FVC=90%, FEV1=35% לפני מרחיבי סימפונות, FEV1=75% לאחר מרחיבי סימפונות, DLCO=105%.

מה האבחנה המתאימה?

א. תפקודי הנשימה מתאימים למחלה רסטרקטיבית עקב פיברוזיס ריאתי

ב. תפקודי הנשימה מתאימים למחלה רסטרקטיבית עקב בעיה מבנית של בית החזה על רקע השמנה

ג. תפקודי נשימה מתאימים למחלה חסימתית עקב אסתמה

ד. תפקודי נשימה מתאימים למחלה חסימתית עקב אמפיזמה קשה

131. בן 84, ברקע: סוכרת, יתר לחץ דם והיפרליפידמיה, אושפז לברור הפרעה חדשה באנזימי כבד.

בבדיקות המעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	138	135-146
K mmol/L	4.8	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	1.2	0.7-1.3
BUN mg/dL	22	5-25
Albumin g/L	36	35-50
WBC 10e3/µL	5.8	4.0-11.0
HgB g/dL	12.8	13.2-17 גבר
Plt 10e3/µL	187	150-450
Bilirubin total mg/dL	5.3	<0.1-1.2
Bilirubin direct mg/dL	4.2	<0.1-0.3
Bilirubin indirect mg/dL	1.1	0.0-0.6
AST (GOT) U/L	66	<7-40
ALT (GPT) U/L	72	<8-39
ALK PHOS U/L	413	46-116
GGT U/L	588	6-42
LDH U/L	456	208-378

מה הבדיקה עם התועלת האבחנתית הרבה ביותר בשלב זה?

א. בדיקה סרולוגית להפטיטיס

ב. אולטרסאונד כבד ודרכי מרה

ג. הפטוגלובין ומשטח בשאלה של המוליזה

ד. סרולוגיה אוטואימונית

132. איזה מהבאים מתאר טיפול המתאים לדמם חריף ממערכת העיכול העליונה בהתאם לאתיולוגיה בגסטרוסקופיה?

א. ב- MALLORY-WEISS TEARS -> טיפול ב- SOMATOSTATIN תוך ורידי

ב. בכיב עם דמם פעיל -> צריבה או הזרקה לכלי הדם

ג. בכיב עם קריש צמוד -> אין מקום לטיפול אנדוסקופי

ד. בדליות -> טיפול ב- CALCIUM CHANNEL BLOCKERS

133. בת 72, מאושפזת לבירור קושי בבליעה וירידה במשקל.
מה באנמנזה יכול לכוון לאטיולוגיה של הקושי בבליעה?

א. דיספגיה למוצקים יכולה להחשיד ל- MYASTHENIA GRAVIS
ב. שיעול קשה בזמן הבליעה יכול להחשיד ל- TRACHEOESOPHAGEAL FISTULA
ג. דיספגיה לנוזלים בלבד חשודה להפרעת תנועה כמו ACALASIA
ד. ODYNOPHAGIA מחשיד להפרעת בליעה נוירומוסקולרית

134. מה מהבאים מהווה גורם סיכון להיפוגליקמיה בקשישים?

א. ירידה בראיה
ב. טיפול ב- QUETIAPINE
ג. טיפול ב- HYDROCHLOROTHIAZIDE
ד. תסמונת קושינג

135. מה נכון לגבי סיכון של מטופל לאחר כריתת טחול לזיהום עתידי ב- Streptococcus Pneumonia?

א. הסיכון עולה ככל שגיל המטופל גבוה יותר
ב. הסיכון עולה ככל שעובר זמן מכריתת הטחול
ג. הסיכון לתמותה מספסיס הוא מעל 50%
ד. טיפול מונע בפניצילין יכול להיות יעיל במניעת זיהום בנוסף לחיסון

136. איזה משפט מתאר נכון את תהליך בירור האטיולוגיה של היפרקלצמיה?

א. רמת $1,25\ (OH)_2D$ מוגברת שוללת ממאירות כגורם להיפרקלצמיה
ב. PTH גבוה בנוכחות אי ספיקה כלייתית מתאים להיפרפרתירואידיזם שלישוני
ג. Milk-alkali syndrome מתאפיין ב- PTH מוגבר
ד. בהיפרקלצמיה משנית לטיפול בתיאזידים רמת PTH גבוהה

137. מה מתאר נכון את הקול השלישי S3 בבדיקת הלב?

א. נובע מהתרוקנות מהירה של הלב בזמן הסיסטולה
ב. יכול להיות ממצא נורמלי בחלק מהקשישים
ג. S3 של חדר ימין משתנה עם הנשימה
ד. יכול להיות ביטוי לאי ספיקת לב, אך ללא משמעות פרוגנוסטית

138. מה האבחנה של המטופל שממנו נלקח משטח הדם שבתמונה 10?

א. THALASSEMIA MINOR

ב. CHRONIC LYMPHATIC LEUKEMIA

ג. THROMBOCYTOSIS

ד. ACUTE MYELOGENOUS LEUKEMIA

139. בת 75, הסובלת מ- non-small-cell lung cancer, שאובחן לאחרונה פונה למלר"ד עקב נפיחות בפנים.

ראו תמונה 11.

מה הטיפול הראשוני המומלץ במצב זה?

א. PREDNISONE במינון 1 מ"ג/ק"ג

ב. טיפול כימותרפי

ג. קרינה מקומית

ד. טיפול כירורגי

140. מה מאפיין late-onset rheumatoid arthritis (LORA)?

א. היעדר Rheumatoid Nodules

ב. הופעה איטית במשך שנים

ג. מעורבות של פרקים קטנים, בעיקר בכפות הידיים

ד. מעורבות של עד 3 פרקים

141. מה מהווה "דגל אדום" המחשיד למחלה משמעותית כגורם לכאב גב?

א. כאב שמחמיר בתנועה

ב. גיל < 70

ג. כאב שמחמיר בלילה

ד. כאב שנמשך יותר משבועיים

142. מה נכון לגבי סיבוכים של טיפול קרינתי?

א. האברים הרגישים ביותר הם הלב, העצמות ומערכת העצבים

ב. הקרנה באזור הראש עשויה לגרום לנזק רטינלי ועיוורון

ג. RADIATION CYSTITIS הוא סיבוך חריף שמופיע בטווח של ימים לאחר הקרינה

ד. ב- 20% מהמטופלים יתפתח גידול סולידי באזור ההקרנה בעשר השנים הראשונות לאחר ההקרנה

143. מה התלונה הקלינית של המטופל בעל האק"ג שבתמונה 12 ?

א. קוצר נשימה וכאב פלויריטי

ב. פלפיטציות לאחר אירוע של סינקופה

ג. ללא תלונות. סובל מיתר לחץ דם לא מאוזן

ד. לאחר פרכוס ותלונות על נימולים בכפות הידיים.

144. בן 72, מתלונן על כאב בחזה. מהי האבחנה המתאימה לפי תיאור אופי הכאב?

א. כאב חד צדדי, מתגבר באופן הדרגתי, מלווה בעליית לחץ דם - Pulmonary embolism.

ב. נמשך כ- 2 דקות, אופי עוויתי - Esophageal reflux

ג. מופיע במאמץ או חשיפה לקור, נמשך כ- 30 דקות - Stable angina

ד. כאב פתאומי, מקרין לגב, ירידה בדופק פריפרי - Acute aortic syndrome

145. מצורפת בדיקת גזים בדם שנלקחה לחולה בטיפול נמרץ:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
PH	7.52	7.37-7.44
PCO2 mmHg	40	40-51
PO2 mmHg	70	65-105
O2 SATURATION %	96	95-98
HCO3 mmol/L	32.7	22-26
BASE EXESS mmol/L	9.1	-3 - +3

מה קרוב לוודאי הבעיה העיקרית של החולה?

א. אי ספיקה כלייתית

ב. אי ספיקה נשימתית

ג. הרעלת סליצילטים

ד. טיפול ב- FUROSEMIDE

146. בן 80 אושפז עקב אוטם שריר הלב. ביום השלישי לאשפוזו נשמעה בהאזנה ללב אוושה חדשה – אוושה סיסטולית קצרה המתחילה עם הקול הראשון.

איזה ממצאים נוספים צפויים בבדיקה גופנית במצב זה?

א. עליה משמעותית בלחץ הדם

ב. בצקת ריאות

ג. דופק לא סדיר

ד. קול רביעי

147. בת 75 תשושה בתפקודה, מתגוררת לבדה, אושפזה בשל בלבול. ברקע מחלה ביפולרית ודמנציה קלה. לאחרונה סבלה מדלקת בדרכי השתן וטופלה ב- NITROFURANTOIN . התרופה היחידה שהיא מקבלת היא LITHIUM .

בבדיקות דם בקבלתה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	155	135-146
K mmol/L	4.8	3.5-5.3
Cl mmol/L	118	95-110
BICARBONATE mmol/L	28	19-25
CREATININE mg/dL	1.1	0.7-1.3
BUN mg/dL	31	5-25
URINE SPECIFIC GRAVITY	1.03	1.005-1.03
URINE OSMOLARITY mmol/kG	700	50-1200

מה הגורם הסביר ביותר להיפרנתרמיה אצל המטופלת?

א. DIABETES INSIPIDUS מרכזי

ב. היפרגליצמיה

ג. ירידה בכמויות שתית מים ודהדרציה

ד. NEPHROGENIC DIABETES INSIPIDUS בעקבות טיפול ב- LITHIUM

148. למי מהבאים יש אבחנה של אנדוקרדיטיס לפי Duke criteria?

א. בן 90, ברקע מסתם אאורטלי מכני, חום 39, שתי תרביות דם עם צמיחה של VIRIDANS STREPTOCOCCI, וירידה ממושכת במשקל

ב.בת 85, חום 38, בבדיקת אקו לב מסה חדשה על מסתם מטרלי, בבדיקות שתן גלומרולונפריטיס ודלקת מפרקים נודדת

ג. בן 75, חום 39, תרבית דם אחת של Coxiella burnetii , בבדיקתו ממצא של janeway lesions ובבדיקות מעבדה rheumatoid factor מוגבר

ד.בת 87, ברקע אי ספיקה של מסתם מטרלי, חום 38, באקו לב עדות למסה חדשה על המסתם, במעבדה לויוקציטוזיס עם נויטרופיליה

149. בן 76, מאושפז במחלקת שיקום לאחר ניתוח החלפת מפרק הירך. משקלו 75 ק"ג.

ברקע - יתר לחץ דם ידוע, שיוחס להיצרות דו צדדית של עורקי הכליה.

מזה שבוע מטופל ב- VANCOMYCIN פומי בגין אבחנת PSEUDOMEMBRANOUS COLITIS. הפסיק לשלשל.

מזה יומיים מטופל ב- AMIKACIN במינון 500 מ"ג ליום עקב זיהום בדרכי השתן.

עקב כאבים עזים באזור הניתוח טופל ב- IBUPROFEN ביום שלפני לקיחת בדיקות המעבדה.

אוכל ושותה. מקבל עירוי נוזלים 1000 סמ"ק ליממה.

בבדיקות דם שגרתיות נמצאה החמרה בתפקודי כליה:

מדד ויחידות	בדיקה בקבלתו למחלקה	בדיקה לאחר שבוע	ערכים תקינים
CREATININE mg/dL	0.7	1.5	0.7-1.3
BUN mg/dL	21	28	5-25

איזה מהגורמים הבאים חשוד ביותר להחמרת התפקוד הכלייתי?

א. VANCOMYCIN

ב. AMIKACIN

ג. IBUPROFEN

ד. דהידרציה

150. מה נכון לגבי בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס?

א. שילוב של בדיקת דם סמוי בצואה וסיגמואידוסקופיה זהה ביעילותו לבדיקת קולונוסקופיה

ב. בדיקת CT COLONOGRAPHY טובה פחות מקולונוסקופיה בזיהוי נגעים קטנים

ג. בדיקת CT COLONOGRAPHY יכולה להראות ממצאים נוספים לא רלוונטיים ולהביא לבירורים מיותרים

ד. בדיקת דם סמוי בצואה לא הוכחה כמונעת תמותה מקרצינומה של המעי הגס

בהצלחה